

NS X4550A * 227180117

CELIA REGINA COUTINHO SOBREIRO

IDADE: 67 PESO: 64 ALTURA: 168 PROFISSÃO: Profª - Apos.
 SINTOMAS: Ronca / lançamento ++ / Refluxo /
 QUEIXAS: Cansaço / Boca seca / MMII edema.
 MEDICAMENTOS: Ex odor / glifage / Sal fútam / Polivitam.
Sempre roncou - Pré diabético / Depressão.

MÉDICO: Drº EnioEXERCÍCIO FÍSICO: Voleibol (2x)HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: 19h JANTAR: NHORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 6 - 7hs

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO Final semana

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1XCIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: — CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: —OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: abaixo SPO2:PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Glaucoma

CIRURGIAS: () NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: — Rinite

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (N) OUTROS

25/08 1º PSG - 2006 - 7.0 e/ev - SpO₂ - 79%2º PSG - 2010 - 19.6 e/ev - SpO₂ - 90%3º PSG - 2011 - 22.8 e/ev - SpO₂ - 80% (CPAP 10,8)4º PSG - 2012 - 2.6 e/ev - SpO₂ - 93% (CPAP 8,0)01/09 P = 8.3 cmH₂OBem adapt.

23 IAH = 2.3

m. de uso: 7h37'Justa.15/09 P = 7.6 cmH₂OBem adaptada,

23

m. de uso: 7:20 e/mintem dias que ruge

IAH = 0.8 e/ev

Fuga = 8.3 e/min

compra JuwelJusta.06/10 P = 7.5 cmH₂OBem adaptada,

23

IAH = 1.3 e/ev

m. de uso: 7h

Fuga = 15.5 lpm

boca seca.Justa13/11 P = 7.5 cmH₂OBoca seca↑ umidif. 4.

2023

IAH = 1.1 e/ev

m. de uso: 7h30'

Fuga = 14 lpm

13/12

P = 7.5 cmH₂OPinicid: 4 cmH₂O.↓ umidif: 2

IAH = 1.5 e/ev

m. de uso: 7h30'

Fuga = 10.9 l/min

nao usou pq condensou água tuboSilvia

15/01 P= 7,5 cmH₂O
2024 IAH= 0,8 elh
m. uso: 6h34
fuga: 19 el/min

umidif 3

Bem adaptada

26/02 P= ~~8,0~~ 7,4 cmH₂O

24 IAH= 3,4

m. de uso: ~~6h50~~ Bem adaptada

fuga: ~~20~~ 11,8 el/min

Natacha

06/02

25

Pte sulata não está

utilizando o equipamento

desde a última vez que ~~ela~~

veio aqui na clínica

Com meu masc. N2O @ e

vai voltar uso

Natacha

17/02

25

P= 7,5 cmH₂O

IAH= 1,2 efes

m. de uso: 6h41

fuga= 12,5 lpm.

Juan.

03/07/25

P= 7,8 cmH₂O (med)

IAH= 3,4 elh

m de uso: 6h53

fuga: 19,2 l/min

Natacha

LAUDO DA POLISSONOGRAMA



NOME: Célia Regina Coutinho Sobreiro Santos
EXAME nº: 1757
SOLICITADO POR: Dr. Wellington Lopes Britto
DATA: 03/06/2010
IDADE: 53 anos

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez CRM: 69730
Especialista em Medicina do Sono - Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP

Comentários:

Exame iniciado às 23h16min e concluído às 06h41min. A latência para o sono foi de 3,5 minutos e a latência para o sono REM, de 154 minutos. O tempo total de sono foi de 355 minutos, com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 80%. A distribuição do sono mostrou 21,6% de estágio 1, 62,8% de estágio 2, 6,5% de estágio 3 e 9,2% de sono REM. No período total de sono permaneceu 90 minutos em vigília, ocorreram 193 microdespertares (índice: 32,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora. O índice de apneia/hipopneia foi de 19,6/hora, sendo 5,2 apneia/hora e 14,4 hipopneia/hora. O número total de eventos respiratórios foi de 116, sendo 0 misto, 116 obstrutivos e 0 central. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 98%, sendo a saturação média de 95% e a mínima de 90%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registrou-se o aumento moderado do índice de apneia/hipopneia (19,6/hora; normal até 4/hora; moderado: 15 a 30 eventos/hora) associado aos episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. Observaram-se também episódios de redução do fluxo aéreo que terminavam em despertares e, às vezes, dessaturações.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio. A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3,5 min; normal até 20 min). A latência para o sono REM estava alongada (154 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 80%; normal: 90% ou acima), microdespertares (193; índice: 32,6/hora; normal até 9/hora) e despertares após o complexo K. Registrou-se o aumento das porcentagens dos estágios 1, estágio superficial do sono (21,6%; normal: 5-8%), e 2 (62,8%; normal: 45-55%), e a redução das porcentagens do estágio 3 (6,5%; normal: 10-11%) e do sono REM (9,2%; normal: 20%).

Ausência de movimentos periódicos de membros. Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 10; máx: 24).

Conclusão final: exame compatível com o ronco e a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA



CENTRO DE TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO

NOME: Célia Regina Coutinho Sobreiro Santos

EXAME nº: 1757-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Willian Nunes de Oliveira

DATA: 26/01/2011

IDADE: 54 anos

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez CRM: 69730
Especialista em Medicina do Sono - Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP

Comentários:

Exame iniciado à 00h57min e concluído às 07h25min. A latência para o sono foi de 45 minutos e a latência para o sono REM, de 139 minutos. O tempo total de sono foi de 257,5 minutos, com eficiência de sono (T T S / T T R)* de 66%. A distribuição do sono mostrou 19,8% de estágio 1, 44,9% de estágio 2, 18,1% de estágio 3 e 17,3% de sono REM. No período total de sono permaneceu 130 minutos em vigília, ocorreram 104 microdespertares (índice: 24,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 22,8/hora, sendo 3,5 apneia/hora e 19,3 hipopneia/hora. O número total de eventos respiratórios foi de 98, sendo 1 misto, 96 obstrutivos e 1 central. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 80%.

(*) T T S $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono T T R $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu ao CTD SONO para a adaptação ao aparelho auto Vantage (Resmed®), sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 2954F). A máscara nasal utilizada foi a Ultra Mirage standard® (Resmed®). A pressão do auto CPAP recomendada foi de 10,8 cm de H₂O. Ela solicitou que a máscara fosse retirada às 02h38min e não a recolocou mais.

Registrou-se o aumento moderado do índice de apneia/hipopneia (22,8/hora; normal até 4/hora; moderado: 15 a 30 eventos/hora) associado aos episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e despertares, com ritmo cardíaco sinusal. Observaram-se episódios de redução do fluxo aéreo que terminavam em despertares e, às vezes, dessaturações.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

A paciente demorou a adormecer (latência para o sono: 45 min; em insones até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (139 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 66%; em insones: 85% ou acima), microdespertares (104; índice: 24,2/hora; normal até 9/hora) e despertares após o complexo K. Registrou-se o aumento das porcentagens dos estágios 1, estágio superficial do sono (19,8%; normal: 5-8%), e 3 (18,1%; normal: 10-11%), e a redução do sono REM (17,3%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (44,9%; normal: 45-55%) permaneceu no limite inferior da normalidade.

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

CONTRATO DE LO

1. DADOS DA LOCADORA
NOME: Fátima e M...
CNPJ: 13...
ENDER: ...